Resumos de Pediatria

Batistaz

Revisão Flash · Respiratório

IVAS na Criança

Do resfriado ao estridor

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

IVAS na criança

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Quase toda IVAS é viral: suporte e orientação; antibiótico só para OMA confirmada, estreptococo provável e sinusite pelo tempo de evolução; estridor pede calma, dexametasona e, se moderado, adrenalina.

1 **Perigo:** não bebe, vomita tudo, convulsão, letargia, TEC > 2 s, gemência, estridor em repouso: referir.

2 **Resfriado:** 7–10 por ano; sem antibiótico, sem descongestionante de rotina; secreção verde não é bactéria.

3 **OMA:** abaulamento moderado/intenso ou otorreia nova sem otite externa. Analgesia já. AIDPI: amoxicilina 50 mg/kg/dia por 8 dias, retorno em 2 dias.

4 **Observar a OMA** (AAP): sem otorreia, unilateral não grave de 6–23 m e não grave ≥ 24 m, com retorno garantido; antibiótico se piora ou sem melhora em 48–72 h. Bilateral < 2 anos ou grave: tratar.

5 **Garganta:** estreptococo = benzatina (< 20 kg 600 mil; ≥ 20 kg 1,2 milhão UI) ou amoxicilina 10 dias. ASLO não.

6 **Sinusite (ABR):** dupla piora após 5 dias ou quadro intenso sem melhora em 14. Sem RX. Amoxicilina 25–50 mg/kg/dia, 7–10 dias.

7 **Crupe:** dexametasona dose única para todos; moderado/grave + adrenalina 1:1.000 pura nebulizada 0,5 mL/kg (máx. 5 mL); observar 2–4 h após a última.

8 **Não é crupe:** tóxico + saliva + sem tosse ladrante = epiglotite; sem resposta à adrenalina = traqueíte bacteriana.

Antibiótico na IVAS

Quadro	Veredito
Resfriado, rinite purulenta	Não
OMA confirmada	Sim, ou observar
Faringite viral	Não
Estreptococo provável	Sim, 10 dias
Crupe viral	Não

Pegadinha

$SatO_2$ normal não descarta obstrução grave: a hipoxemia no crupe é tardia e já indica UTI.

Checklist antes do plantão

- ☐ Reconheço os sinais gerais de perigo
- ☐ Localizo o estridor pela voz e pela tosse
- ☐ Diagnostico OMA pelo abaulamento
- ☐ Sei quando observar e quando tratar a OMA
- ☐ Uso as pistas e o McIsaac na garganta
- ☐ Prescrevo benzatina pelo peso
- ☐ Sei os critérios de RSAB e os sinais orbitários
- ☐ Dou dexametasona e adrenalina no crupe
- ☐ Sei quando o estridor é epiglotite ou traqueíte